CUESTIONARIO ENDOCRINOLOGIA 1	2024
1. Un paciente de 70 años consulta por un cuadro de astenia y malestar general. Se solicitan exámenes que muestran calcemia: 14,8 mg/dl, albúmina plasmática: 3,6 g/dl, PTH: disminuida, fosfatasas alcalinas: elevadas. El diagnóstico más probable es:	a.Hiperparatiroidismo primario b.Cáncer medular de tiroides c.Hipercalcemia maligna d.Hipercalcemia ficticia e.Insuficiencia suprarrenal
2. Un paciente de 40 años presenta aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 cm de diámetro, en relación a la glándula tiroides, que asciende con la deglución. Se solicita una ecografía cervical, que lo visualiza de aspecto sólido-quístico, sin adenopatías y una TSH que resulta 1,0 UI/L. La conducta más adecuada es:	a.Resolver quirúrgicamente de inmediato b.Solicitar TAC de cuello c.Realizar punción aspiración con aguja fina d.Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo e.Solicitar niveles plasmáticos de calcitonina y tiroglobulina
3. Una paciente de 30 años presenta un bocio de tamaño moderado, difuso. No presenta síntomas y su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?	a.Iniciar levotiroxina en dosis bajas b.Solicitar TAC de cuello c.Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo d.Solicitar TSH y anticuerpos anti-TPO e.Solicitar T4 y tiroglobulina
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto al cáncer papilar de tiroides?	a.Es el cáncer de tiroides más frecuente b.Se disemina por vía linfática c.Su tratamiento es la tiroidectomía total d.Se beneficia del uso de yodo radiactivo e.Una vez tratado, debe seguirse periódicamente con triyodotironina plasmática, para detectar precozmente las recidivas
5. La asociación de amenorrea secundaria e hirsutismo es muy sugerente de:	a.Hiperplasia suprarrenal congénita b.Climaterio c.Hipogonadismo hipergonadotrópico d.Síndrome de ovario poliquístico e.Hipogonadismo hipogonadotrópico
6. Una mujer de 23 años, asintomática, acude a chequeo médico, donde se le solicita una TSH que resulta 3,1 UI/L (VN: 0,4 – 4,0 UI/L) y una T4, que resulta 13,5 ug/ml (VN: 4,5 – 12,5 ug/ml). No tiene patologías conocidas, pero usa anticonceptivos orales. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar anticuerpos anti-TPO y solicitar ecografía cervical b.Solicitar anticuerpos TRAB y solicitar contigrafía tiroidea c.Iniciar levotiroixina oral d.Derivar para inicio de yodo radiactivo e.Explicar normalidad de su situación y observar evolución
7. ¿Cuál de las siguientes patologías es causa de hiponatremia?	a.Diabetes insípida b.Enfermedad de Cushing c.Hipogonadismo hipogonadotrópico d.Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética e.Hipertiroidismo
8. Una paciente de 30 años consulta por un cuadro de marcado malestar general y ortostatismo. Al examen físico está sudorosa, con FC: 110x' y PA: 90/60 mmHg, que no aumenta, luego de administrar un litro de suero fisiológico. Se aprecia hiperpigmentación de las manos y la mucosa oral y su hemoglucotest es de 63 mg/dl. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas b.Solicitar metanefrinas urinarias c.Administrar levotiroxina oral d.Administrar corticoides endovenosos e.Solicitar resonancia magnética nuclear de silla turca
9. Un paciente presenta un cuadro de 3 meses de evolución de astenia, asociado a disminución de las masas musculares, con obesidad de predominio central. Al examen físico se aprecian estrías	a.Resonancia magnética nuclear de silla turca b.Metanefrinas en orina c.TAC de abdomen

Lia...

abdominales, “cara de luna” y tungo. Se solicita una prueba de supresión corta, que resulta alterada, por lo que se realiza una prueba de supresión larga, la que no suprime y se piden niveles de ACTH, que resultan indetectables. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?	d.Niveles plasmáticos de cortisol y DHEAs e.Radiografía de tórax
10. Una paciente de 50 años consulta por astenia y dificultad para ver de un mes de evolución, que ha ido en aumento. Al examen físico presenta aumento de tamaño de las manos y pies, la nariz y los labios. Además, se aprecia un defecto campimétrico, compatible con una hemianopsia heterónima bitemporal. En sus exámenes generales destaca glicemia de ayuno de 180 mg/dl. ¿Cuál de es el diagnóstico más probable?	a.Tumor hipofisiario productor de TSH b.Síndrome de compresión del tallo hipofisiario c.Tumor hipofisiario productor de GH d.Neoplasia endocrina múltiple tipo 2 e.Síndrome poliglandular

CUESTIONARIO 2 ENDOCRINOLOGÍA	
1.Una paciente de 34 años hipotiroidea, en tratamiento con 100 ug al día de levotiroxina, se embaraza. Usted la controla al tercer mes de embarazo y trae una TSH de 3,5 UI/L. La conducta más adecuada es:	a.Mantener indicaciones b.Aumentar la dosis de levotiroxina c.Solicitar T4 y T3 libres d.Disminuir la dosis de levotiroxina e.Reemplazar la levotiroxina por levotriyodotironina
2. Una paciente de 43 años sufre un accidente de tránsito, con golpe en la cabeza. Evoluciona con poliuria y polidipsia. Se solicitan una glicemia, que resulta normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?	a.Iniciar una tiazida b.Indicar restricción de agua libre a 800 cc al día c.Solicitar niveles plasmáticos de ADH d.Solicitar osmolaridades plasmática y urinaria e.Iniciar tratamiento con furosemida
3. Una paciente de 30 años consulta por malestar general y síncopes, por hipotensión ortostática. Al examen físico está muy decaída, con FC: 130x', regular, PA: 70/30 mmHg, mucosas con hiperpigmentación de lengua y cara interna de las mejillas. Se solicitan exámenes, que muestran hiponatremia, hiperkalemia y glicemia de 60 mg/dl. La conducta más adecuada es:	a.Administrar suero fisiológico e iniciar noradrenalina endovenosa b.Administrar alfabloqueantes y luego betabloqueantes c.Solicitar test de supresión con dexametasona d.Administrar suero fisiológico e hidrocortisona por vía endovenosa e.Administrar suero fisiológico y solicitar resonancia magnética de silla turca
4. ¿Qué patología se asocia al cáncer medular de tiroides y debe ser descartada antes de tratarlo?	a.Hipoparatiroidismo b.Feocromocitoma c.Enfermedad de Addison d.Enfermedad de Cushing e.Acromegalia
5. Una paciente de 18 años presenta astenia, sensación de calor y diarrea, desde hace algunas semanas. Además, ha sentido molestias en los ojos. Al examen físico se constata FC: 110x', PA: 120/80, piel fina y húmeda. Se palpa un bocio difuso de tamaño moderado y se constata una ligera proptosis izquierda. El diagnóstico es:	a.Enfermedad de Basedow Graves b.Tiroiditis de Quervein c.Cáncer de tiroides d.Tiroiditis de Hashimoto e.Tiroiditis de Riedel
6. Un paciente de 60 años presenta astenia y debilidad muscular. Al examen físico se aprecia atrofia de la musculatura de las 4 extremidades, asociado a estrías abdominales y "cara de luna". Además, se solicitan exámenes generales, entre los que destaca glicemia de ayuno de 180 mg/dl. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas b.Solicitar niveles plasmáticos de ACTH c.Solicitar test de tolerancia a la glucosa d.Solicitar radiografía de tórax e.Administrar cortisol
7. Una paciente presenta dolor en el cuello, asociado a palpitaciones y temblor. Al examen físico se aprecia aumento de volumen tiroideo, que es muy doloroso al presionarlo con los dedos. El diagnóstico más probable es:	a.Cáncer anaplásico b.Tiroiditis aguda c.Tiroiditis subaguda d.Enfermedad de Basedow Graves e.Quiste folicular roto
8. Un paciente de 35 años presenta un nódulo tiroideo, que se moviliza con la deglución. Se solicita una TSH, que resulta 4,0 UI/L y una ecografía cervical, que lo demuestra de aspecto sólido-quístico y de 2 cm x 1 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:	a.Iniciar levotiroxina b.Solicitar tiroglobulina c.Solicitar calcitonina d.Solicitar biopsia por punción con aguja fina e.Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
9. Un paciente de 45 años consulta por impotencia. Refiere que ha disminuido su deseo sexual y que además se ha sentido más débil de lo habitual. Se solicitan exámenes, que demuestran disminución de la testosterona plasmática, por lo que se solicita LH, que resulta muy alta. ¿Cuál de las siguientes opciones es compatible con este cuadro?	a.Lesión hipotalámica b.Tumor hipofisiario productor de LH c.Hiperprolactinemia d.Sección del tallo hipofisiario e.Daño testicular

Lia...

10. Una mujer de 45 años inicia oligomenorrea, con ciclos menstruales cada 2 a 3 meses, a lo que se le agregan bochornos. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada para iniciar terapia de reemplazo hormonal?	a.Estrógenos solos b.Progestágenos solos c.Estrógenos más progestágenos d.Raloxifeno e.Agonistas de la GnRH
11. Paciente de 56 años es traído al servicio de urgencias por cefalea intensa, vómitos y visión doble que se iniciaron hace 40 minutos. Al examen destaca estrabismo divergente y hemianopsia heterónima bitemporal. El diagnóstico más probable es:	a.Apoplejía hipofisiaria b.Síndrome de Sheehan c.Síndrome de sección del tallo hipofisiario d.Síndrome de silla turca vacía e.Síndrome de compresión de tallo hipofisiario
12. Un paciente de 60 años es diagnosticado de hipotiroidismo por una tiroiditis de Hashimoto por lo que se inicia tratamiento con levotiroxina 50 ug al día. Además de la evolución clínica, ¿Qué examen o exámenes es/son más adecuado(s) para controlar a este paciente?	a.Niveles plasmáticos de hormona tiroestimulante b.Niveles plasmáticos de tiroxina c.Niveles plasmáticos de tiroxina libre d.Niveles plasmáticos de tiroglobulina e.Niveles plasmáticos de anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea
13. En una paciente con síndrome de Sheehan, la prueba de progesterona y la prueba de estrógeno + progesterona, serán respectivamente:	a.Positiva y positiva b.Positiva y negativa c.Negativa y positiva d.Negativa y negativa e.Positiva y no interpretable
14. Un paciente presenta hipercalcemia e hipofosfemia, asociadas a litiasis renal y osteoporosis. El diagnóstico más probable es:	a.Insuficiencia renal crónica b.Hiperparatiroidismo primario c.Hipercalciuria primaria d.Hipercalcemia maligna e.Hipervitaminosis D
15. Un paciente de 26 años, con hipertensión arterial, se realiza exámenes generales, en los que destaca hipokalemia, por lo que se solicita índice de aldosterona/ARP, el que resulta 60 (VN: menor a 25). El tratamiento de la patología descrita es:	a.Cirugía vascular de arterias renales b.Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensiana c.Tiazidas d.Propanolol e.Espironolactona
16. Una niña de 7 años presenta olor axilar adulto desde hace algunos días. Se puede afirmar que:	a.Ha iniciado su pubertad de manera precoz b.Ha iniciado su pubertad normalmente c.Probablemente presentará talla baja d.Se debe descartar una hiperplasia suprarrenal congénita e.Es una variante normal del desarrollo
17. hombre de 50 años, fumador de 50 paquetes años, con antecedente de disnea de 3 meses de evolución, asociada a tos, sin estudio, acude a urgencias por deterioro progresivo de sus funciones cognitivas, incluyendo desorientación y sopor. No tiene antecedentes de trauma. La exploración física no muestra otras alteraciones. Sus exámenes de laboratorio muestran: Na+ plasmático 118 mEq/l, osmolalidad plasmática 240 mOsm/kg, glicemia 90 mg/dl, urea 22 mg/dl. Osmolalidad urinaria: 290 mOsm/kg, Na+ urinario: 35 mEq/l. ¿Cuál de los siguientes cuadros es el más probable?:	a.Insuficiencia suprarrenal crónica. b.Diabetes insípida central. c.Polidipsia compulsiva. d.Síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética (SSIADH). e.Reajuste del osmostato.
18. ¿En qué condición es preferible solicitar T4 libre en lugar de T4 corriente?	a.Tiroiditis subaguda b.Tiroiditis de hashimoto c.Hipotiroidismo congénito d.Uso de anticonceptivos orales e.Insuficiencia cardíaca

Lia...

19. La hiperprolactinemia en hombres se manifiesta frecuentemente como:	a.Ginecomastia aislada b.Galactorrea aislada c.Impotencia sexual y disminución de la libido d.Astenia y vómitos e.Ginecomastia y galactorrea
20. Hombre de 22 años, consulta por infertilidad. Al examen físico destacan testículos de tamaño pequeño. La testosterona plasmática está disminuida y la FSH aumentada. El espermiograma demuestra azoospermia. El diagnóstico más probable es:	a.Síndrome de Klinefelter b.Disgenesia gonadal primaria c.Hipopituitarismo d.Hipogonadismo hipogonadotrópico e.Orquitis atrófica idiopática

CUESTIONARIO 3 ENDOCRINOLOGÍA	
1.Una paciente de 50 años consulta por un cuadro de astenia y debilidad de 3 semanas de evolución. Refiere además náuseas y cambios en la coloración de las manos. Al examen físico se aprecia hiperpigmentación de las manos y la mucosa oral. El examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica es:	a.Resonancia magnética de silla turca b.Cortisol libre urinario de 24 horas c.ACTH plasmática d.Prueba de supresión con dexametasona e.Prueba de estimulación con ACTH
2. Una paciente de 34 años diagnosticada de hipotiroidismo, en tratamiento con 100 ug de levotiroxina al día, desde hace 6 semanas, se realiza una TSH de control, que resulta 7,2. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar T3 y decidir conducta según resultado b.Solicitar T4 libre y decidir conducta según resultado c.Mantener el tratamiento y controlar en 6 semanas más d.Aumentar la dosis de levotiroxina e.Disminuir la dosis de levotiroxina
3. Una mujer de 70 años se realiza una densitometría ósea como estudio de rutina, obteniéndose un Z-score de -0,3 y un T-score de -2,1. El diagnóstico más probable es:	a.Sana b.Osteopetrosis c.Osteopenia d.Osteoporosis postmenopáusica e.Osteoporosis secundaria
4. Un paciente de 75 años, fumador de 40 paquetes-año, presenta un cuadro de baja de peso y malestar general, de 2 meses de evolución, al que hoy se le agregó compromiso de conciencia. En sus exámenes destaca una natremia de 120 mEq/L. El diagnóstico más probable es:	a.Síndrome de secreción ectópica de ACTH b.Enfermedad de Cushing c.Enfermedad de Addison d.Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética e.Diabetes insípida
5. Un paciente de 65 años se realiza pruebas de función tiroidea, como parte de un chequeo médico, presentado los siguientes valores: TSH: 9,1 UI/L (VN: 0,4 – 4,0), T4 libre: 0,3 ng/dl (VN: 0,7 – 1,9), T3 libre: 0,4 pg/ml (VN: 0,8 – 4,1). La conducta más adecuada es:	a.Solicitar anticuerpos anti-TPO y decidir conducta según resultados b.Solicitar perfil lipídico y decidir conducta según resultados c.Observar evolución y controlar con nuevos exámenes en 3 meses d.Iniciar levotiroxina (T4) e.Iniciar triyodotironina (T3)
6. Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia, presenta impotencia sexual y disminución de la libido. Además, refiere astenia. Al preguntarle dirigidamente, refiere pérdida de las erecciones matinales. Al examen físico presenta disminución del vello corporal, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar niveles plasmáticos de prolactina, testosterona, FSH y LH b.Solicitar niveles plasmáticos de testosterona, dihidroepiandrosterona e inhibina c.Solicitar niveles plasmáticos de SHBG y DHEAs d.Solicitar niveles plasmáticos de FSH, LH y 17-OH-Progesterona e.Solicitar cariograma
7. Un paciente de 34 años consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa un nódulo tiroideo de 2 cm de diámetro, duro, que asciende con la deglución. Se Solicita una ecografía que lo visualiza de aspecto sólido, sin adenopatías cervicales asociadas. Se realiza una punción aspirativa con aguja fina, obteniéndose una citología compatible con un carcinoma folicular (lesión folicular con displasias de alto grado). La conducta más adecuada es:	a.Iniciar tratamiento con yodo radiactivo b.Realizar tiroidectomía total y seguir con niveles plasmáticos de calcitonina c.Realizar tiroidectomía total, con linfadenectomía cervical d.Realizar tiroidectomía total y en segunda instancia tratar con yodo radiactivo e.Realizar tiroidectomía parcial e iniciar levotiroxina en dosis altas
8. Un paciente de 35 años acude a control médico, con un perfil bioquímico, que como única alteración muestra una calcemia de 12,5	a.Solicitar PTH b.Solicitar calcio iónico

mg/dl. La albúmina plasmática es de 4,0 g/dl. La conducta más adecuada es:	c.Solicitar colonoscopía, radiografía de tórax y TAC de abdomen y pelvis d.Iniciar furosemida y controlar en 3 meses e.Iniciar hidroclorotiazida y controlar en 3 meses
9. Una paciente de 50 años presenta una hipertensión arterial de difícil manejo, que inició hace cerca de un mes y que ha presentado varias crisis hipertensivas, a pesar de estar en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida en dosis máximas. Además, refiere crisis de pánico y en su examen físico destaca FC: 130 latidos por minuto y PA: 170/110 mmHg. Su electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal. El diagnóstico de sospecha es:	a.Hipertiroidismo b.Feocromocitoma c.Hiperaldosteronismo primario d.Tiroiditis subaguda e.Síndrome de secreción ectópica de ACTH
10. La causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal en Chile es actualmente:	a.Autoinmune b.Tuberculosis c.Postquirúrgica d.Congénita e.Viral
11. La asociación entre temblor, fiebre, taquicardia y dolor cervical, es sugerente de:	a.Cáncer diferenciado de tiroides b.Cáncer anaplásico de tiroides c.Quiste del conducto tirogloso d.Enfermedad de Basedow graves e.Tiroiditis de Quervain
12. Un paciente de 35 años, sin enfermedades crónicas conocidas, se realiza un TAC de cerebro, por estudio de un traumatismo encéfalo-craneano, el que no visualiza fracturas ni hemorragias, sin embargo, demuestra la presencia de un tumor hipofisiario de 8 mm de diámetro. Su TSH, prolactina, cortisol basal y niveles de testosterona son normales. La conducta más adecuada es:	a.Observar evolución b.Iniciar bromocriptina c.Resolver quirúrgicamente d.Solicitar niveles plasmáticos de ACTH, CRH y GnRH e.Solicitar test de la sed
13. Una mujer, sin antecedentes de importancia, presenta amenorrea desde hace 5 meses, asociado a galactorrea, a pesar de contar con una prueba de embarazo negativa. La conducta más adecuada para iniciar el estudio es:	a.Prueba de estrógeno + progesterona b.Prueba de progesterona c.Niveles plasmáticos de LH y FSH d.Niveles plasmáticos de prolactina e.Niveles plasmáticos de progesterona y estradiol